ESTUDIANTES

EJE 1 · Transformaciones del cuidado y humanización

Manos limpias, niños saludables: Adaptación sensorial y visual del lavado de manos en la comunidad TEA

Acchura S.[1], Blanco J.[2], Carriego S.[3], Espindola S.[4], Gonza F.[5], González M.[6], Gonzalez S.[7], Machado J.[8], Melo C.[9]

Instituto superior de Formación técnica 201, Carrera de Enfermería - Salud Pública I

1 INTRODUCCIÓN

- *El lavado de manos es una medida fundamental para la prevención de enfermedades en la población general. Sin embargo, en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), las particularidades en la integración sensorial (hipersensibilidad táctil, hídrica o sonora) y las barreras en la comunicación o secuenciación convierten a esta rutina higiénica en un desafío particular.*

2 OBJETIVOS

Objetivo General: Promover el hábito correcto del lavado de manos en la comunidad TEA mediante actividades adaptadas e inclusivas que fomenten la salud preventiva y el autocuidado

Objetivos Específicos: [1]Enseñar la técnica de lavado con apoyos visuales y pictogramas secuenciales.
[2]Brindar herramientas de intervención a familias, docentes y acompañantes terapéuticos (ATE).
[3]Reducir aversiones sensoriales asociadas al agua y al jabón en el hogar y la escuela.

3 METODOLOGÍA

Diseño y estrategia: Intervención comunitaria y pedagógica con enfoque visual, cualitativo y participativo.

Población y ámbito: Niñeces y adolescencias pertenecientes a la comunidad TEA, sus familias, cuidadores principales, docentes y ATEs en el ámbito comunitario y escolar.

Estrategia de intervención:
Elaboración de cartelería y soportes con pictogramas secuenciales claros.

Adaptación del entorno (uso de jabón líquido de textura suave, control de temperatura templada).

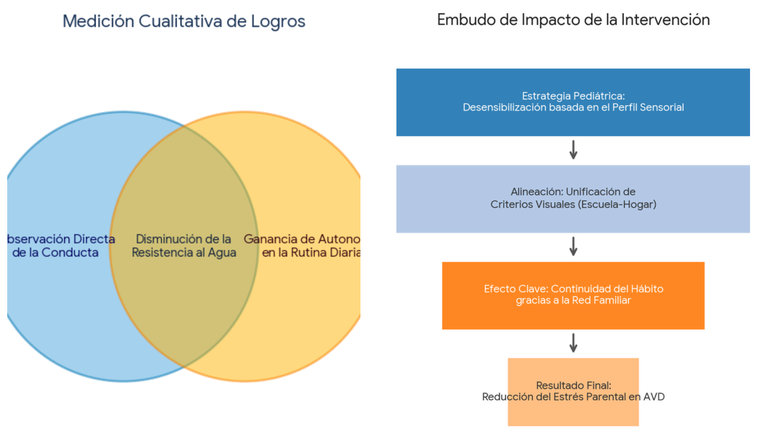
Implementación de sistemas de refuerzo positivo mediante estampillas/stickers y felicitación explícita.

Capacitación directa a la red de apoyo para dar continuidad en el hogar.

4 RESULTADOS



Figura 1. Pictogramas del lavado de manos. Fuente: . Secuencia adaptada a partir de los pictogramas de Sergio Palao. Procedencia: ARASAAC (2026). Licencia: CC (BY-NC-SA).



Esta intervención se planteó como un reporte cualitativo enfocado en la desensibilización sistemática de la rutina higiénica en pediatría. Se logró que el niño ganara autonomía y disminuyera notablemente su resistencia al agua, evidenciado a través de la observación directa de su conducta. La clave del éxito radicó en la participación activa de la familia y en la unificación de criterios visuales entre el hogar y la comunidad educativa, lo que además redujo significativamente el estrés parental en las actividades de la vida diaria (AVD).

Las principales dificultades surgieron al intentar romper con las estructuras rígidas de los procedimientos estandarizados. Inicialmente, costó coordinar la red de apoyo para mantener la constancia y el mismo enfoque visual en ambos entornos, lo que ponía en riesgo la continuidad del hábito.

Finalmente, se aprendió que en la enfermería pediátrica es obligatorio priorizar el perfil sensorial individual de cada niño antes de imponer cualquier rutina. La flexibilidad del estímulo, el respeto por los tiempos singulares del paciente y el diseño de un abordaje paso a paso junto a su entorno afectivo son los pilares fundamentales para garantizar un cuidado humanizado y eficiente.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

El abordaje interdisciplinario y humanizado de las barreras sensoriales reafirma el rol activo de enfermería en la construcción de cuidados inclusivos. Adaptar las intervenciones a las necesidades individuales fortalece la confianza de la persona con TEA, promueve el derecho a la salud y garantiza una mejor calidad de vida e independencia en las actividades cotidianas.

La secuencia visual cumplió el objetivo de estructurar el lavado de manos, mitigando la resistencia táctil y promoviendo la higiene independiente en niños con TEA. El alcance de esta intervención demostró ser una solución comunitaria de bajo costo y alta efectividad para entornos familiares y escolares. Sin embargo, la principal limitación radica en que los resultados están condicionados al perfil sensorial específico de cada paciente, requiriendo adaptaciones individuales en casos de hipersensibilidad severa para garantizar su sostenibilidad.

6 APORTE A ENFERMERÍA

Este proyecto humaniza el cuidado al integrar la neurodiversidad en los procedimientos básicos de salud. Reafirma el rol educador de enfermería, ofreciendo una herramienta visual estandarizada, de bajo costo y fácil replicabilidad en el hogar, escuelas y salas de internación. Así, empodera a las familias y transforma barreras sensoriales en autonomía e inclusión para la comunidad

7 REFERENCIAS

Organización Mundial de la Salud. (2020). Directrices de la OMS sobre la higiene de las manos en la atención de la salud. OMS.
Organización Panamericana de la Salud. (2021). Promoción de la salud comunitaria y prevención de enfermedades en poblaciones vulnerables. OPS.